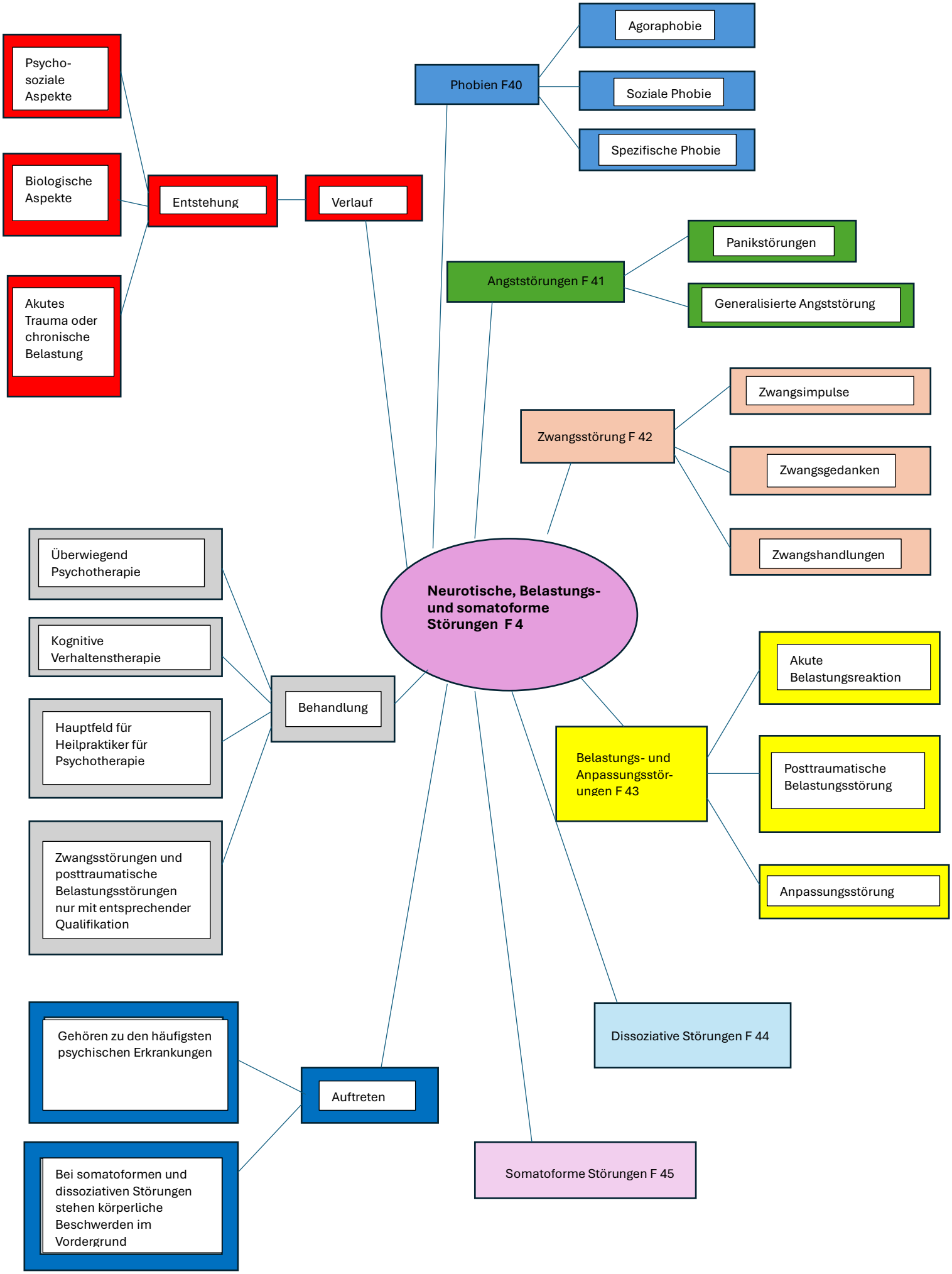

Psycho-soziale Aspekte
Biologische Aspekte
Akutes Trauma oder chronische Belastung
Entstehung
Verlauf
Phobien F40
Agoraphobie
Soziale Phobie
Spezifische Phobie
Angststörungen F 41
Panikstörungen
Generalisierte Angststörung
Zwangsstörung F 42
Zwangsimpulse
Zwangsgedanken
Zwangshandlungen
Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen F 4
Überwiegend Psychotherapie
Kognitive Verhaltenstherapie
Hauptfeld für Heilpraktiker für Psychotherapie
Zwangsstörungen und posttraumatische Belastungsstörungen nur mit entsprechender Qualifikation
Behandlung
Akute Belastungsreaktion
Belastungs- und Anpassungsstör-ungen F 43
Posttraumatische Belastungsstörung
Anpassungsstörung
Dissoziative Störungen F 44
Gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen
Auftreten
Bei somatoformen und dissoziativen Störungen stehen körperliche Beschwerden im Vordergrund
Somatoforme Störungen F 45

ICD-10 F 4
Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen

- Psychische Störungen, denen keine organische Ursache oder eine andere psychiatrische Erkrankung zugeordnet werden kann und bei denen der Betroffene keinen Realitätsverlust erleidet, werden als neurotische Störungen bezeichnet. Dazu zählen:
    - Angsterkrankungen
    - Zwangsstörungen
    - Dissoziative Störungen/Konversionsstörungen

Angst ist an sich kein pathologisches Symptom, wenn es als Warnzeichen für eine tatsächliche Bedrohung oder Gefahr auftritt.
Wird die Angst zum Selbstläufer und tritt vermehrt auf, ohne dass es dafür einen realen Anlass gibt liegt eine Angststörung vor.

Ätiologie – multifaktorielle Genese

- Biologische und genetische Faktoren
    - Familiäre Häufung
    - Das limbische System und die Amygdala (Mandelkern) sind überaktiv und reagieren empfindlicher auf bestimmte Reize
    - Veränderungen in der Funktion von Neurotransmittern wie Serotonin, Noradrenalin und GABA können die Angstregulation im Gehirn beeinflussen
- Kognitive und lerntheoretische Aspekte
    - Modelllernen
    - Informative Lernerfahrung (Information, Warnungen oder Erzählungen) usw.
    - Angst vor der Angst
    - Vermeidung
- Psychodynamische Aspekte
    - Stress, Traumata, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, belastende Lebensereignisse

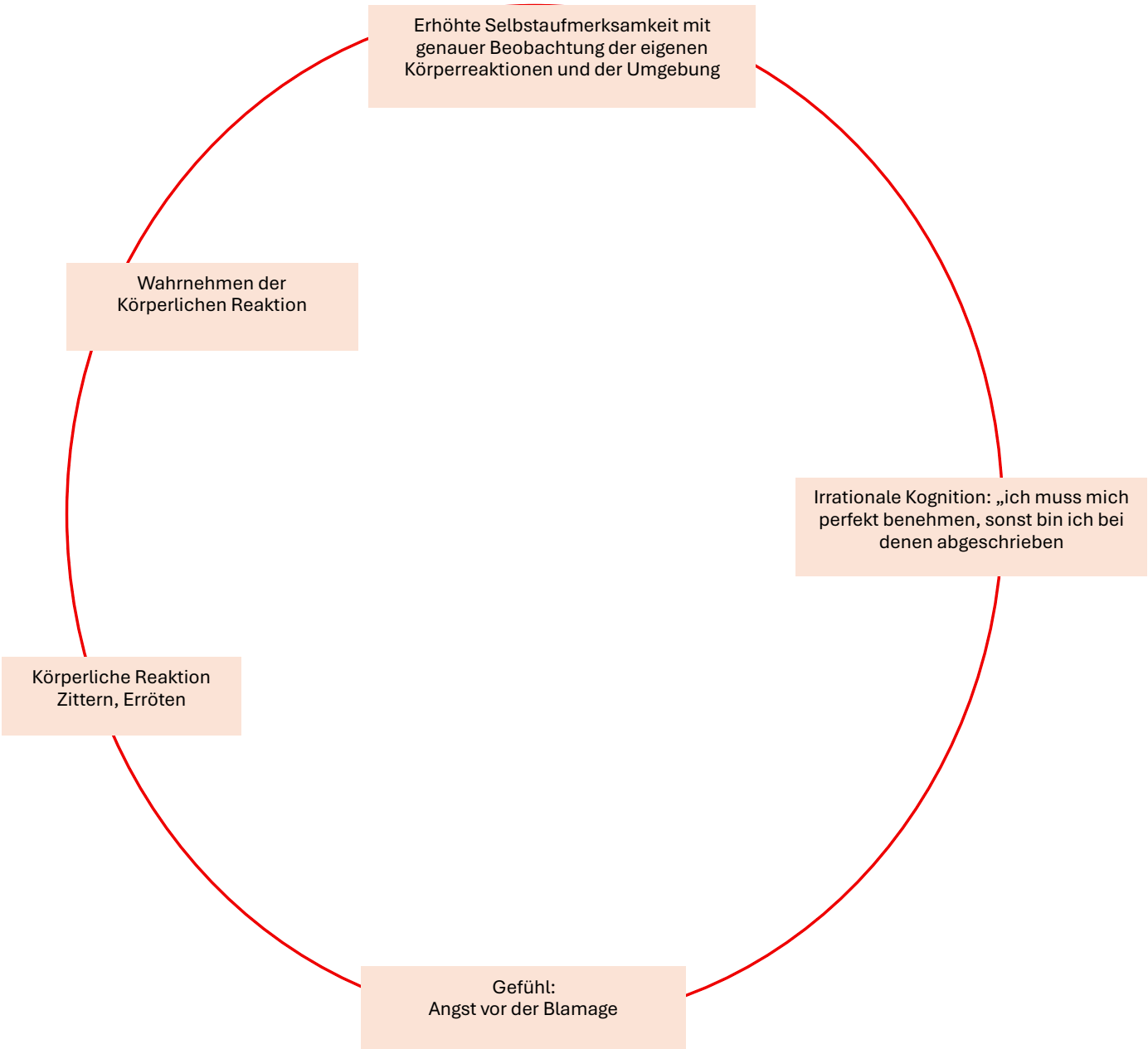
Der Auslöser der meisten F 4 Störungen sind individuell bedeutsame und negative Lebensereignisse, genetische und psychische Vulnerabilität sowie ungünstige Lern- und Bewältigungsprozesse. Die spezifische Ausprägung ist abhängig vom Zusammenspiel der verschiedenen Einflussfaktoren und der individuellen Biografie.

Kognitive und lerntheoretische Verarbeitungsprozesse

Fallgeschichte
Eine korpulente 32-jährige Mutter von zwei Schulkindern stellt sich beim Heilpraktiker vor. Sie berichtet, dass sie vorletzte Woche zur Abklärung beim Hausarzt gewesen sei, weil sie dachte, sie würde einen „Herzanfall“ erleiden. Es sei körperlich aber alles in Ordnung gewesen. Ihr jüngster Sohn sei vor 2 Monaten in die Schule gekommen, und sie habe die Vormittage wieder frei. Deswegen würde sie gerne wieder in Teilzeit arbeiten und habe sich im Internet nach einer neuen Stelle umgesehen. Sie sei gelernte Bürokauffrau und letzte Woche auf dem Weg zu einem potenziellen Arbeitgeber gewesen. Als sie in die U-Bahn gestiegen sei, sei ihr plötzlich ganz komisch geworden, sie habe extrem zu schwitzen angefangen, und ihr Herz raste. Sie habe eine Angst wie noch nie bekommen. Sie meinte, sie müsse sterben, ihr Herz würde versagen. An der nächsten Station habe sie die U-Bahn panikartig verlassen und ihren Mann angerufen. Der sei gekommen und habe sie zum Hausarzt gebracht. Dort sei es ihr aber schon viel besser gegangen, und der Arzt habe keinen Hinweis auf einen Herzinfarkt gefunden. Er habe ihr geraten abzunehmen.
Sie sei dann gleich mit ihrer Freundin am nächsten Tag zum „Nordic Walking“ gegangen. Das habe sie aber aus Angst wieder abgebrochen, weil das Herz wieder so stark zu klopfen angefangen habe. Auch fühle sie sich derzeit nicht in der Lage, eine neue Stelle zu suchen. Letzte Woche vor dem Computer habe plötzlich alles wieder angefangen. Herzrasen, Schwitzen, Zittern und diese wahnsinnige Angst. Ihr Mann habe versucht, sie telefonisch zu beruhigen. Der Spuk sei dann auch vorbeigegangen, aber währenddessen sei es unerträglich, sie habe geglaubt, sie würde es nicht überleben. Dieselben Anfälle habe sie dann noch zweimal beim Frühstücken und unter der Dusche erlebt. Ihr Mann sage immer, es könne nichts Körperliches sein, und zwischenzeitlich werde er schon etwas ungehalten, wenn sie über ihre Ängste spreche. Sie traue sich kaum noch auf die Straße. Das U-Bahn-Fahren sei ihr seit vorletzter Woche ein „Graus“. Zu dieser Praxis habe sie immerhin laufen können. Am liebsten gehe sie nur noch in Begleitung aus dem Haus, aber das sei auf Dauer ja keine Lösung.

Zum Fall
Die arbeitssuchende Mutter erlebt beim U-Bahn-Fahren (**neutraler Reiz**) eine Panikattacke (subjektiv als lebensbedrohliche Situation wahrgenommen). Weil sie eine erneute Panikattacke befürchtet, meidet sie fortan die U-Bahn. Das U-Bahn-Fahren ist also vom neutralen zum **konditionierten Reiz** geworden (**klassische Konditionierung**). Das Abklingen der Angst nach fluchtartigem Verlassen der U-Bahn verstärkt in der Frau das **Vermeidungsverhalten (Operante Konditionierung).**

⇒ Angsterkrankungen neigen durch kognitive Verarbeitungsprozesse zur Chronifizierung
Teufelskreis der Angst am Beispiel der sozialen Phobie



Angststörungen: Administrative Prävalenz (ab 18 Jahre)

Angst und die sie begleitenden körperlichen und psychischen Reaktionen machen Menschen wachsam und handlungsbereit, um akute Bedrohungs- oder Stresssituationen besser bewältigen zu können. Wenn Ängste, Sorgen oder Befürchtungen jedoch angesichts der realen Bedrohung unverhältnismäßig oder unangemessen, langandauernd und stark beeinträchtigend sind, werden sie als Angststörung beschrieben. Je nach Auslöser und Art der Angstreaktion werden unter anderem Panikstörung, soziale Phobie und generalisierte Angststörung unterschieden. Die Krankheitslast von Angststörungen wird aufgrund von hoher Prävalenz und Chronifizierungsrisiko, häufiger Komorbidität (insbesondere mit Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen) und erhöhter Sterblichkeit als hoch eingeschätzt (**WHO 2023**, **Yang et al. 2021**).

Der Anteil der gesetzlich Versicherten, bei denen die Diagnose einer Angststörung in der ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung dokumentiert wurde, wird als administrative Prävalenz oder auch Diagnoseprävalenz bezeichnet. Sie wird davon beeinflusst, dass die meisten Betroffenen keine professionelle Hilfe aufgrund der psychischen Beschwerden aufsuchen und Angststörungen im Gesundheitssystem häufig übersehen werden (**Alonso et al. 2018**, **Heinig et al. 2021**).

Ergebnisse

Im Jahr 2023 erhielten in Deutschland 7,9 % der Erwachsenen die Diagnose einer Angststörung in der ambulanten Versorgung. Bei Frauen lag der Anteil mit 9,9 % nahezu doppelt so hoch wie bei Männern (5,4 %). Im Vergleich der Altersgruppen fiel die administrative Prävalenz von Angststörungen bei den unter 30-Jährigen sowohl bei Frauen (8,6 %) als auch bei Männern (4,3 %) am geringsten aus. Die höchsten Werte zeigten bei Frauen die 60- bis 69-Jährigen (11,4 %), bei Männern die 50- bis 59-Jährigen (6,4 %). Unter den Bundesländern fiel die administrative Prävalenz von Angststörungen bei Frauen in Baden-Württemberg (8,8 %) und bei Männern in Brandenburg (4,8 %) am

geringsten aus, während Berlin bei beiden Geschlechtern die höchsten Werte erreichte (Frauen: 12,6 %; Männer: 6,8 %).

Im Zeitverlauf nahm die administrative Prävalenz von Angststörungen zwischen den Jahren 2012 (5,8 %) und 2023 zu. Der stärkste Zuwachs war im Jahr 2020 zu verzeichnen. Die aktuellsten Entwicklungen im Jahr 2023 sind, im Gegensatz zum Vorjahr, von einem erneuten Zuwachs gekennzeichnet, insbesondere bei Frauen zwischen 18 und 29 Jahren. Über die gesamte Zeitspanne von 2012 bis 2023 betrug der Anstieg der administrativen Prävalenz von Angststörungen bei Männern + 1,7 Prozentpunkte (+ 47,7 %) und bei Frauen + 2,4 Prozentpunkte (+ 32,2 %). Im Altersvergleich waren die Zuwächse bei Frauen in der ältesten Gruppe ab 80 Jahre am größten, bei Männern bei den 70- bis 79-Jährigen.

Fazit

Angststörungen werden in der ambulanten Versorgung häufig und seit 2012 zunehmend diagnostiziert. Als Ursachen der Entwicklungen werden Veränderungen des Hilfesuchverhaltens von Betroffenen sowie der Diagnose- und Kodierpraxis von Behandelnden diskutiert. Zugleich können Belastungen durch Krisen eine Zunahme neuer Fälle mit Angststörungsdiagnose zur Folge habe. Diese trug beispielsweise während der COVID-19-Pandemie (**Bohlken et al. 2021**) zu einem markanten Anstieg der administrativen Prävalenz im Jahr 2020 bei. Von einer zunehmenden Belastung der Bevölkerung durch **Angstsymptome** in Zeiten multipler Krisen wird auch 2022 und 2023 im Vergleich zu 2021 ausgegangen. Diese schlägt sich möglicherweise mit dem zuletzt verstärkten Zuwachs von Angststörungsdiagnosen bei jungen Frauen (18 – 29 Jahre) auch im Versorgungssystem nieder.

Da Angststörungen in epidemiologischen Studien zu den häufigsten psychischen Störungen in der Bevölkerung zählen, erscheint ihre vergleichsweise geringe administrative Prävalenz erklärungsbedürftig (**Thom et al. 2019**). Während die Entstehung von Angststörungen vorrangig durch Prävention ihrer sozialen Ursachen verhindert werden kann (**Kirkbride et al. 2024**), sollten auch die verfügbaren Behandlungsansätze durch eine akkurate Feststellung von Angststörungen im Versorgungsgeschehen umfassend genutzt werden.

Störung	Gesamt %	Frauen %	Männer %
Panikstörung F41.0	2,0	2,8	1,2
Agoraphobie F40.0	4,0	5,6	2,3
Soziale Phobie F40.1	2,7	3,6	1,9
Generalisierte Angststörung F41.1	2,2	2,9	1,5
Spezifische Phobie F 40.2	10,3	15,4	5,1
Zwangsstörung F 42	3,6	4,0	3,3
PTBS F 43.1	2,3	3,6	0,9
Angststörung gesamt F40, F41	15,3	21,3	9,3

Prävalenzangaben DEGS1 – MH (18-79 Jahre) RKI

Störung	Gesamt %	Frauen %	Männer %
Panikstörung F41.0	2,0	2,8	1,2
Agoraphobie F40.0	4,0	5,6	2,3
Soziale Phobie F40.1	2,7	3,6	1,9
Generalisierte Angststörung F41.1	2,2	2,9	1,5
Spezifische Phobie F 40.2	10,3	15,4	5,1
Zwangsstörung F 42	3,6	4,0	3,3
PTBS F 43.1	2,3	3,6	0,9
Angststörung gesamt F40, F41	15,3	21,3	9,3

Prävalenzangaben DEGS1 – MH (18-79 Jahre) RKI

Entstehungsmechanismen

- **Genetik**: erbliche Komponenten bei praktisch allen genannten Störungen
- **Neurobiologie**: Dysbalancen von Neurotransmittern und Veränderungen in Hirnarealen
- **Lernerfahrungen**: durch Erziehung, frühe Traumatisierungen, negative Modell- und Konditionierungsprozesse
- **Akute Belastungen/Trauma**: v.a für PTBS, aber auch als Auslöser für andere Störungen

Phobische Störungen

Phobien entstehen meist durch das Zusammenwirken von genetischer Veranlagung, neurobiologischen Faktoren (z.B. Ungleichgewicht in Neurotransmittern), ungünstigen Lernerfahrungen in Kindheit und Jugend, bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen (z.B. geringes Selbstwertgefühl) und psychosozialen Faktoren (Elternverhalten, Überbehütung, soziale Isolation). Akute Belastungserlebnisse oder traumatische soziale Erfahrungen können als Auslöser wirken.

Angststörungen: Panik und Generalisierte Angststörung

Auch hier wirken genetische Prädispositionen, Störungen in Neurotransmittersystemen (z.B. Serotonin, Noradrenalin, GABA), sowie Veränderungen in Angstrezeptoren und Hirnarealen (insbesondere die Amygdala). Psychosoziale Faktoren wie Stress, belastende Lebensereignisse, schwierige Kindheitserlebnisse oder negative Lernerfahrungen verstärken die Entwicklung der Störung. Kognitiv werden angstauslösende Körperempfindungen oft fehlinterpretiert, was einen Teufelskreis der Angst in Gang setzt.

Zwangsstörung

Die Entstehung der Zwangsstörung ist ebenfalls multifaktoriell. Sie wird durch genetische Faktoren, neurobiologische Veränderungen (vor allem Störungen im Serotoninsystem und speziellen Gehirnstrukturen), sowie psychosoziale Faktoren (kontrollierende Erziehung, Stresserfahrungen) beeinflusst. Negative Lernerfahrungen und ungünstige Problemlösestrategien spielen ebenfalls eine Rolle

Therapie

- Psychoedukation
- Kognitive Verhaltenstherapie:
  - Expositionsverfahren
  - Kognitive Umstrukturierung
- Entspannungsmethoden
- Pharmakotherapie
- Psychohygiene
- Traumatherapie

Zu Psychoedukation → Klienten nach Diagnosestellung über die Erkrankung aufklären und beraten. Wichtig ist, dass der Klient versteht, dass er/sie **nicht vital bedroht** ist, sondern gute Behandlungsaussichten hat und eine günstige Prognose.

Zu kognitive Verhaltenstherapie:

Formen der Expositionstherapie

- In-vivo-Exposition / reale Konfrontation
- In-sensu-Exposition / hierbei stellt sich der Klient die angstauslösende Situation vor
- Virtual-Reality-Exposition / computergenerierte Umgebungen bei Flugangst/ Höhenangst
- Graduierte Exposition: schrittweise Konfrontation / Standardverfahren
- Flooding: massierte Exposition / direkte Konfrontation
- Reaktionsmanagement / spezifisch bei Zwangsstörungen genutzt

Kognitive Umstrukturierung : Fallbeispiel Panikattacke

- **Automatischer Gedanke:** „wenn ich in der U-Bahn eine Panikattacke bekomme, werde ich sterben oder keinen Ausweg finden."
- **Sokratische Fragen:** „was spricht dafür, dass sie sterben? Haben sie solche Situationen schon einmal sicher überstanden?"
- **Beweissammlung:** Die Frau erinnert sich, dass sie Panikattacken zwar unangenehm, aber noch nie gefährlich waren und sie immer die Situation verlassen konnte.
- **Alternative Gedanken:** Eine Panikattacke fühlt sich furchtbar an, ist aber nicht lebensgefährlich. Ich kann Hilfe rufen oder die Bahn verlassen.
- **Entkatastrophisierung:** Auch wenn ich mich unwohl fühle, kann ich die Situation kontrollieren oder mich aus ihr entfernen.
- **Fokusverlagerung:** Die Frau lernt, sich auf sichere Aspekte der Umgebung zu konzentrieren statt nur auf ihre Angstgefühle.

Vorgehen bei der Expositionstherapie:

- Erstellen der Angsthierarchie
- Planung der Exposition
- Durchführung der Konfrontation
- Reflexion und Nachbesprechung
- Wiederholung und Steigerung

Exposition mit Reaktionsmanagement:

1. **Ausgangspunkt:** Der Patient hat Angst vor Verunreinigung und wäscht seine Hände ständig, um die Angst zu reduzieren.
2. **Vorbereitung:** Gemeinsam mit dem Therapeuten wird eine Angsthierarchie erstellt, z.B. :
   - Hände mit leichtem Schmutz berühren (niedrige Angststufe),
   - Hände berühren ohne zu waschen
   - Längeres Nicht-Waschen nach bestimmten Aktivitäten (höhere Angststufen)
3. **Exposition:** Der Patient setzt sich nun bewusst den angstauslösenden Situationen aus (z.B. berührt absichtlich etwas „Schmutziges" und versucht gleichzeitig, das übliche Zwangsverhalten (Händewaschen) zu unterlassen.
4. **Reaktionsmanagement:** Während der Exposition wird das Vermeidungsverhalten (Händewaschen) bewusst unterlassen, um die Angstgefühle vollständig zu erleben und ohne Fluchtmechanismus zu durchleben.
5. **Ziel:** Durch das wiederholte Aushalten der Angstsymptome lernt der Patient, dass keine Katastrophe eintritt, auch wenn er der Angst nicht sofort durch Waschen entkommt. Die Angst nimmt mit der Zeit ab (Habituation), und die Zwangshandlung verliert ihre Kontrolle.
6. **Unterstützung:** Der Therapeut begleitet die Expositionsübungen, hilft bei der Bewältigung von auftretenden Ängsten und plant gemeinsam mit dem Patienten weitere Übungen, auch für zu Hause.

Systematische Desensibilisierung:

1. **Angsthierarchie erstellen**
2. **Entspannungstechniken erlernen**
3. **Schrittweise Konfrontation:** die angstauslösenden Situationen werden nacheinander in der Hierarchie durchgespielt, beginnend mit der am wenigsten ängstigenden. Dabei aktiv die zuvor gelernte Entspannung angewendet, um die Angstreaktion zu reduzieren.
4. **Wiederholung und Steigerung**
5. **Anwendung im Alltag**

Entspannungsmethoden:

- **Progressive Muskelentspannung PME** Diese Technik schult das Bewusstsein für Muskelspannung und Entspannung, hilft Stress abzubauen, und vermindert körperliche Angstsymptome wie Muskelverspannungen, Herzrasen oder Atemnot. Dadurch wirkt sie beruhigend auf Körper und Geist. Regelmäßiges Training der PME kann die Fähigkeit verbessern, in angstauslösenden Situationen gezielt zu entspannen und so Angstgefühle zu reduzieren.
  1. **Position einnehmen**
  2. **Aufmerksamkeit auf Muskeln richten** z.B. Hände oder Arme, Nacken, Bauch, Beine, Füße usw.
  3. **Anspannen:** Spanne diese Muskelgruppe ganz bewusst und fest an, ohne Schmerzen zu verursachen, und halte die Spannung für ca. 5-7 Sekunden
  4. **Entspannen:** Lasse die Spannung plötzlich los und spüre die Entspannung für etwa 15-20 Sekunden nach
  5. **Systematisch vorgehen:** Gehe nacheinander z.B. die Muskelgruppen von oben nach unten durch
  6. **Atmung beachten:** Atme dabei ruhig und gleichmäßig
  7. **Wiederholen:** Die Übung dauert etwa 10-15 Minuten. Übe regelmäßig, am besten täglich.

- **Tiefenatmung** Die Tiefenatmung aktiviert den Parasympathikus, den Teil des Nervensystems, der für Entspannung und Erholung zuständig ist. So werden Herzfrequenz und Blutdruck gesenkt, und das Gefühl von Angst kann merklich abnehmen. – Diese Methode ist überall anwendbar und besonders hilfreich in akuten Angstsituationen oder zur regelmäßigen Beruhigung. Regelmäßige Übung vertieft die Wirkung.

1. **Position:** Setze dich bequem hin oder lege dich entspannt hin, die Hände können auf den Bauch gelegt werden, um das Atmen zu spüren.
2. **Atmen durch die Nase:** Atme langsam und tief durch die Nase ein, dabei hebt sich der Bauch, weil das Zwerchfell aktiviert wird. Zähle dabei ruhig bis 4
3. **Kurze Pause:** Halte den Atem für 1-2 Sekunden an
4. **Langsam ausatmen:** Atme langsam durch den leicht geöffneten Mund aus, zähle dabei bis 6 oder länger
5. **Wiederholen:** Wiederhole diesen Atemrhythmus für 5-10 Minuten oder bis ein Gefühl der Ruhe einsetzt.

Pharmakotherapie

- Zum Einsatz kommen Antidepressiva vornehmlich vom Typ der SSRI wie Citalopram (Cipramil) oder Paroxetin (Seroxat). Die Therapie sollte über einen Zeitraum von 12 Monaten gehen. Der Patient muss informiert werden, dass das Antidepressivum die Angst zunächst verstärken kann!
- Neben SSRI können auch MAO-Hemmer eingesetzt werden
- Benzodiazepine können in der Akuttherapie, z.B. zum Durchbrechen einer Panikattacke eingesetzt werden
- Betablocker werden zur Reduzierung der körperlichen Symptomatik eingesetzt

Psychohygiene

- Psychohygiene umfasst sowohl theoretische Ansätze als auch praktische Methoden zur Förderung der mentalen Gesundheit
- Der Ansatz verfolgt ähnlich wie die medizinische Hygiene das Ziel, „Infektionen“ oder „Schäden“ am Geist durch präventive und kurative Maßnahmen zu verhindern.

Maßnahmen der Psychohygiene

- Förderung von Selbstfürsorge und Achtsamkeit gegenüber den eigenen psychischen Bedürfnissen
- Stressbewältigung durch Entspannungsübungen, regelmäßige Pausen, soziale Unterstützung und gesunde Lebensgewohnheiten
- Kommunikation und Ausdruck von Gefühlen wie Ärger oder Trauer, um innere Belastungen zu verarbeiten
- Integration von Psychohygiene in den Alltag, z.B. durch Hobbys, Sport, soziale Kontakte oder Supervision in beruflichen Kontexten.

Ziel der Psychohygiene

- Psychohygiene soll das seelische Wohlbefinden stärken, Krisen vorbeugen und dazu beitragen, belastende Situationen besser zu bewältigen
- Sie unterstützt dabei, Resilienz aufzubauen und eine gesunde Balance zwischen Belastung und Erholung herzustellen.

Traumatherapie

Vor und während der Therapie wird die Art und der Schweregrad des Traumas geklärt: Typ I: einmaliges Trauma, Typ II: wiederholtes Trauma;
Die Traumatherapie verläuft typischerweise in drei wesentlichen Phasen:

1. **Phase: Stabilisation** -Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Techniken wie die Imagination eines sicheren Ortes, Atemübungen, Entspannungstechniken und das Erlernen von Selbstberuhigungsstrategien.
2. **Phase**: **Traumabearbeitung (Konfrontation)** – dies kann durch Verhaltenstherapie mit kontrollierter Exposition, EMDR oder anderen Methoden geschehen. Ziel ist es, die belastenden Erinnerungen schrittweise zu verarbeiten, die Angstreaktionen zu verringern und den emotionalen Schmerz zu regulieren.
3. **Phase**: **Integration** – hier wird das Erlebte in die eigene Lebensgeschichte integriert. Ziel ist, eine neue, belastungsfreie Sichtweise zu etablieren, das Selbstwertgefühl zu stärken und Ressourcen für den Alltag zu aktivieren.

Therapeutisches Vorgehen bei psychogenen Störungen F 4		
Verdachtsdiagnose	**Therapeutisches Vorgehen**	**Praktische Hinweise**
Anpassungsstörung	. Psychoedukation: über Folgen und Verlauf einer Anpassungsstörung aufklären . eigene Therapieform, falls hierfür geeignet: Da es eine erkennbare Auslösesituation für die Störung gibt, können Sie mit ihrer Therapie helfen, die belastende Situation zu verarbeiten.	. Oft ist es hilfreich, dass es bei Trauerfällen in vielen Kulturen ein Trauerjahr gibt, in dem die Betroffenen durch ihre Kleidung anzeigen, dass sie noch dabei sind, sich an die neue Situation „anzupassen“, dass die Verarbeitung also länger andauern wird. . Hinweis, dass auch eine Trennung, eine Scheidung, ein Organverlust, der Verlust des Arbeitsplatzes oder die Diagnose einer schweren Erkrankung Verlusterlebnisse sind, an die der Einzelne sich „anpassen“ muss. . Hinweis auf Erfahrung, dass Betroffene bei Verarbeitung des Verlusterlebnisses vier Phasen durchlaufen: 1. Verleugnung/Betäubung 2. Wechselbad der Gefühle 3. Sich-Trennen von Bildern, Gegenständen, Kleidung 4. Neurorientierung Weitere Informationen zu den Trauerphasen im Internet unter www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/trauer.html.
Posttraumatische Belastungs-störung PTBS	. Psychoedukation über Ursachen und Folgen einer PTBS (Flashbacks, Albträume, gesteigerte Vigilanz, Schlafstörungen, Ängste, Depressionen etc.) . Traumatherapie . bei Bedarf Einsatz von Psychopharmaka (Antidepressiva, Benzodiazepine u.a.)	. Häufige Frage in der Prüfung: was macht so ein Traumatherapeut? Da gibt es augenblicklich zwei Haupttherapierichtungen: Verhaltenstherapie und EMDR . Verhaltenstherapie: Expositionstechnik, kombiniert mit kognitiven Verfahren. Beispiele: wiederholtes Erzählen des Traumas, um die emotionale „Ladung“ zu reduzieren, Erstellen eines Drehbuchs über das belastende Erlebnis mit wiederholtem „Nachspielen“ der Situation in verteilten Rollen, graduierte Konfrontation mit der zentralen Szene, zunächst gedanklich (in sensu), später „in vivo“ . eine weitere oft gestellte Frage: Was sind die Phasen einer Behandlung mit Traumatherapie? 1. Stabilisierungsphase (Ressourcentechniken mit medikamentöser Unterstützung) 2. Graduierte Konfrontation mit dem Trauma 3. Integrationsphase
Spezifische (isolierte) Phobien (z.B. Spinnenphobie, Klaustrophobie, Höhenangst, Flugangst) Agoraphobie (z.B. Angst vor Plätzen, Menschenmengen, Alleinreisen etc.)	. klassische Verhaltenstherapie (graduierte Exposition oder Flooding)	. Häufige Zusatzfrage: Der Klient bekommt erst in sechs Monaten einen Termin beim Verhaltenstherapeuten. Was machen Sie in der Zwischenzeit mit ihm? . Einüben von Atem- und Entspannungstechniken in Kombination mit der angstauslösenden Situation „in sensu“ (z.B. Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen). Beispiel: Der Therapeut hilft dem Klienten, sich in einen Zustand der Entspannung zu bringen. Dann stellt der Klient sich gedanklich die angstauslösende Situation vor und macht die Erfahrung, dass der Angstpegel im entspannten Zustand weniger wird. Nach einiger Zeit kann der Klient diese Technik allein anwenden, bevor er z.B. mit dem Aufzug oder mit der überfüllten U-Bahn fährt. Auf diese Weise fühlt er sich nicht hilflos ausgeliefert.

Therapeutisches Vorgehen bei psychogenen Störungen F 4		
Verdachtsdiagnose	**Therapeutisches Vorgehen**	**Praktische Hinweise**
Anpassungsstörung	. Psychoedukation: über Folgen und Verlauf einer Anpassungsstörung aufklären . eigene Therapieform, falls hierfür geeignet: Da es eine erkennbare Auslösesituation für die Störung gibt, können Sie mit ihrer Therapie helfen, die belastende Situation zu verarbeiten.	. Oft ist es hilfreich, dass es bei Trauerfällen in vielen Kulturen ein Trauerjahr gibt, in dem die Betroffenen durch ihre Kleidung anzeigen, dass sie noch dabei sind, sich an die neue Situation „anzupassen“, dass die Verarbeitung also länger andauern wird. . Hinweis, dass auch eine Trennung, eine Scheidung, ein Organverlust, der Verlust des Arbeitsplatzes oder die Diagnose einer schweren Erkrankung Verlusterlebnisse sind, an die der Einzelne sich „anpassen“ muss. . Hinweis auf Erfahrung, dass Betroffene bei Verarbeitung des Verlusterlebnisses vier Phasen durchlaufen: 5. Verleugnung/Betäubung 6. Wechselbad der Gefühle 7. Sich-Trennen von Bildern, Gegenständen, Kleidung 8. Neurorientierung Weitere Informationen zu den Trauerphasen im Internet unter www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/trauer.html.
Posttraumatische Belastungs-störung PTBS	. Psychoedukation über Ursachen und Folgen einer PTBS (Flashbacks, Albträume, gesteigerte Vigilanz, Schlafstörungen, Ängste, Depressionen etc.) . Traumatherapie . bei Bedarf Einsatz von Psychopharmaka (Antidepressiva, Benzodiazepine u.a.)	. Häufige Frage in der Prüfung: was macht so ein Traumatherapeut? Da gibt es augenblicklich zwei Haupttherapierichtungen: Verhaltenstherapie und EMDR . Verhaltenstherapie: Expositionstechnik, kombiniert mit kognitiven Verfahren. Beispiele: wiederholtes Erzählen des Traumas, um die emotionale „Ladung“ zu reduzieren, Erstellen eines Drehbuchs über das belastende Erlebnis mit wiederholtem „Nachspielen“ der Situation in verteilten Rollen, graduierte Konfrontation mit der zentralen Szene, zunächst gedanklich (in sensu), später „in vivo“ . eine weitere oft gestellte Frage: Was sind die Phasen einer Behandlung mit Traumatherapie? 4. Stabilisierungsphase (Ressourcentechniken mit medikamentöser Unterstützung) 5. Graduierte Konfrontation mit dem Trauma 6. Integrationsphase
Spezifische (isolierte) Phobien (z.B. Spinnenphobie, Klaustrophobie, Höhenangst, Flugangst) Agoraphobie (z.B. Angst vor Plätzen, Menschenmengen, Alleinreisen etc.)	. klassische Verhaltenstherapie (graduierte Exposition oder Flooding)	. Häufige Zusatzfrage: Der Klient bekommt erst in sechs Monaten einen Termin beim Verhaltenstherapeuten. Was machen Sie in der Zwischenzeit mit ihm? . Einüben von Atem- und Entspannungstechniken in Kombination mit der angstauslösenden Situation „in sensu“ (z.B. Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen). Beispiel: Der Therapeut hilft dem Klienten, sich in einen Zustand der Entspannung zu bringen. Dann stellt der Klient sich gedanklich die angstauslösende Situation vor und macht die Erfahrung, dass der Angstpegel im entspannten Zustand weniger wird. Nach einiger Zeit kann der Klient diese Technik allein anwenden, bevor er z.B. mit dem Aufzug oder mit der überfüllten U-Bahn fährt. Auf diese Weise fühlt er sich nicht hilflos ausgeliefert.

Verdachtsdiagnose	Therapeutisches Vorgehen	Praktische Hinweise
Soziale Phobien	. Kombination von kognitiver und klassischer Verhaltenstherapie	. da die soziale Angst durch damit verknüpfte irrationale Gedanken (Kognitionen) ausgelöst wird, ist die kognitive Verhaltenstherapie im Augenblick die Therapieform, die am häufigsten angewandt wird. Die wichtigsten hierbei verwendeten Techniken sollten Sie im Mündlichen in Kürze erklären können: -Erkennen der angstmachenden Gedanken (z.B. durch ein Angsttagebuch) -kognitive Umstrukturierung der negativen -Kognitionen mithilfe des Therapeuten -Einüben der neuen Kognitionen in sozialen Situationen (Exposition) - vor der eigentlichen Exposition „in vivo“ werden oft sozial belastende Situationen im Rollenspiel vorweggenommen und mithilfe der neu erarbeiteten Kognitionen eingeübt (Training sozialer Kompetenzen in der Gruppe)
Panikstörung	. kognitive Verhaltenstherapie	. da die Panikattacken ohne erkennbare Auslöser auftreten, ist es wichtig, die damit verknüpften Gedanken zu erkennen und zu verändern. Die drei Stufen (Merkwort: „EVA“) der kognitiven Verhaltenstherapie entsprechen der unter „soziale Phobien“ beschriebenen, also: - **Erkennen** der angstmachenden Gedanken, die kurz vor einer Panikattacke auftreten (z.B. durch ein Angsttagebuch) - **Verändern**: kognitive Umstrukturierung der negativen Kognitionen mit Hilfe des Therapeuten - **Anwenden**: Einüben der neuen Kognitionen in sozialen Situationen (Exposition) . ergänzende Fragen zur Panikstörung: - Was ist der Unterschied zwischen einer Panikattacke und einer Panikstörung - Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Angstanfall und einer Panikattacke
Generalisierte Angststörung	.kognitive Verhaltenstherapie	.keine Panikattacken als typisches Merkmal! Panikattacken können bei schweren Formen gelegentlich auftreten, sind aber nach ICD-10 kein Diagnosekriterium. .Hauptmerkmal: Die Betroffenen sind andauernd besorgt und ängstlich in Bezug auf Dinge des alltäglichen Lebens (z.B. dass jemand aus dem näheren Umfeld erkranken oder einen Unfall haben könnte, wie wohl die berufliche Zukunft sein wird etc.) .Die Sorgen und Ängste beziehen sich auf viele verschiedene Bereiche des alltäglichen Lebens, es gibt also keine spezifischen Auslösesituationen. Ursache für die Sorgen und Ängste sind die Gedanken der Betroffenen. Am erfolgreichsten deshalb augenblicklich: die kognitive Verhaltenstherapie in drei Schritten „EVA“, wie oben beschrieben. .Manchmal fragen die Prüfer: Was sonst noch kann man therapeutisch tun? Dann kann es hiflreich sein, die Betroffenen zu fragen, ab wann die Ängste erstmalig aufgetreten sind (z.B. nach dem Tod eines nahen Verwandten, nach einem schweren Unfall oder einer lebensbedrohlichen Krankheit). Wenn eine solche konkrete Belastungssituation erkennbar ist, ist auch eine Verarbeitung der „Ursituation“ vorstellbar mit dem Ziel, dass die Betroffenen realisieren: „Es war schlimm, aber die Gefahr ist heute vorüber. Wenn sie eine Therapieform erlernt haben, mit der Sie aufdeckend und auflösend arbeiten, können sie dies vorsichtig einbringen.